UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

CARDIOLOGIE
Dyspnée dans le cadre d'une insuffisance cardiaque congestive
Station avec patient / sans geste clinique

Nom du rédacteur : LAURENT Leria
Date de rédaction : 21/10/2022
Relecture intra-ou transdisciplinaire :
Relecture et validation COPIL :

Situation de départ : Dyspnée (SDD-162)

Domaine de compétence principal : Entretien/interrogatoire
Domaine de compétence secondaire : Stratégie diagnostique

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :
- Décrire les caractéristiques cliniques et les circonstances de survenue, et grader la dyspnée
- Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :
- Connaître les modalités du diagnostic d'un OAP cardiogénique (item 234, rang A)
- Connaître les examens complémentaires à réaliser en urgence dans l'OAP cardiogénique (item 234, rang A)

Patient simulé nécessaire à la station : OUI, homme de 70-75 ans

Matériel nécessaire à la station :

- 1 brancard
- 1 solution hydro-alcoolique
- 1 fiche infirmière avec les constantes vitales (cf. annexe)

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé. Si l'étudiant-médecin pose une question non listée ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Synopsis : Vous avez 72 ans et vous êtes à la retraite, vous habitez avec votre femme. Depuis quelques semaines, vous vous sentez à court de souffle, et cela s'est progressivement empiré durant ce laps de temps. Maintenant, vous n'arrivez plus à monter jusqu'au 3ème étage, où se trouve votre appartement, par les escaliers, vous devez utiliser l'ascenseur. Si vous ne placez pas quelques oreillers sous votre tête, vous n'arrivez pas à dormir.
Cette nuit, vous vous êtes réveillé avec la sensation d'étouffer. Votre femme a appelé les pompiers et vous avez été transporté aux urgences.
Un étudiant en médecine va vous interroger.

Identité/Contexte	M. DUPONT Michel, 72 ans À la retraite (ancien taxi) Marié, 2 enfants Vit à domicile avec sa femme Vous aimez bien regarder la télé à la maison, votre femme vous reproche de ne pas sortir plus souvent.
Antécédents	Votre médecin dit que vous « avez de la tension ». Votre père a fait une « crise cardiaque » à l'âge de 50 ans. Vous « avez du cholestérol ». Vous n'avez pas d'allergies.
Médicaments actuels / Toxiques	Vous prenez 2 médicaments pour la tension, depuis très longtemps (dont vous ne vous souvenez plus du nom) Vous avez 1 médicament pour le cholestérol (dont vous ne vous souvenez plus du nom) Vous fumez 1 paquet de cigarettes par jour depuis que vous avez 20 ans, vous n'avez pas réussi à diminuer malgré les conseils de votre médecin.

	Vous buvez de l'alcool « un peu comme tout le monde », 1 petit verre par repas ne fait de mal à personne après tout !
État d'esprit / comportement	Vous êtes **assis** sur votre brancard, **penché vers l'avant** en prenant appui sur vos mains. Vous refusez catégoriquement de vous allonger. Parole : vous êtes très essoufflé et parlez de manière saccadée Angoisse : très forte, vous avez beaucoup de mal à respirer
Déroulement du scénario	Vous êtes assis sur votre brancard, penché vers l'avant en prenant appui sur vos mains. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : « **Je me suis réveillé en m'étouffant… J'ai très peur docteur, j'ai l'impression de me noyer »*** Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf. tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. L'étudiant ne doit normalement pas vous examiner.
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Au bout de 6 minutes, **si l'étudiant ne vous a pas déjà indiqué la prise en charge** qu'il comptait mettre en place, vous pouvez demander à l'étudiant : *« Mais docteur, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver ce que j'ai ? »*

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Si les questions sont trop compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »	
« Depuis quand avez-vous du mal à respirer ? »	Je n'ai jamais été très sportif, mais depuis quelques semaines je suis plus essoufflé que d'habitude.
« Dans quelles circonstances vous sentez-vous essoufflé ? »	Récemment, c'était surtout en montant les escaliers. Je ne peux plus monter jusqu'à chez moi (au 3ème étage), je suis obligé de prendre l'ascenseur ou de m'arrêter à mi-chemin !
« Depuis combien de temps avez-vous du mal à respirer dans la position allongée ? » *Ou* *« Combien d'oreillers utilisez-vous pour dormir ? »*	Depuis quelques semaines je ne peux pas dormir sans avoir mis 2/3 oreillers sous ma tête. Mais cette nuit, ça m'a carrément réveillé !
« Avez-vous eu d'autres signes inhabituels durant ces dernières semaines ? »	Oui, parfois j'ai la sensation de sentir mon cœur battre très fort dans ma poitrine. C'est assez désagréable.
« Avez-vous déjà perdu connaissance / eu un malaise dans ces dernières semaines ? »	Il y a 2 jours je me suis senti un peu partir, ma femme m'a dit que j'étais tout gris. Mais je n'ai pas perdu connaissance.
« Avez-vous pris du poids ces derniers temps ? »	Oui ! Et pourtant docteur, j'essaie de faire attention. Ma femme dit que j'ai les jambes comme des poteaux.
« Avez-vous mal dans la poitrine ? »	J'ai beaucoup de mal à respirer, mais c'est tout.
« Avez-vous des allergies ? »	Non, pas que je sache.

« Prenez-vous des médicaments ? »	Oui, j'en ai 2 pour la tension, et 1 pour le cholestérol. Je ne me souviens plus de leurs noms.
« Avez-vous déjà eu des symptômes de ce type ? »	Je n'ai jamais été très sportif mais je n'avais jamais été aussi essoufflé, ça me fait très peur.
« Y a-t-il déjà eu des maladies dans votre famille ? »	Mon père a fait une crise cardiaque à 50 ans.
« Quelles sont vos habitudes de vie ? »	J'aime bien rester à la maison, ma femme trouve que je devrais sortir plus souvent.
« Fumez-vous ? »	Oui. Je fume 1 paquet par jour depuis que j'ai 20 ans.
« Buvez-vous de l'alcool ? »	Oh, 1 petit verre par repas comme tout le monde !
« Consommez-vous d'autres drogues ? »	Ah ça non !

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne de garde aux urgences.

M. Dupont, 72 ans, est amené par les pompiers au beau milieu de la nuit, car il s'est réveillé « en s'étouffant ».

L'infirmier vous prévient qu'il est très anxieux et refuse de s'allonger dans son brancard.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser un interrogatoire ciblé afin d'orienter votre diagnostic étiologique. L'examen physique n'est pas attendu.
2. Expliquer au patient le(s) examen(s) complémentaire(s) que vous allez demander afin de le prendre en charge.

Annexe – Fiche infirmière de relevé des constantes

À afficher dans la salle / poser sur le brancard.

M. DUPONT Michel (72 ans)

FC : 115 bpm

TA : 150/90

FR : 22/min

SpO_2 : 87%

Température : 37,5 °C

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Interrogatoire	
Demande au patient le motif de sa venue	
Demande le moment d'apparition des symptômes	
Demande les éléments déclenchants des symptômes	
Évalue l'intensité de la dyspnée (demande dans quelles activités le patient s'est senti essoufflé / limité)	
Demande des précisions sur la gêne occasionnée en position allongée (nombre d'oreillers et/ou difficultés à s'endormir)	
Recherche la notion de palpitations	
Recherche la notion de sensation de malaise (lipothymie) / perte de connaissance (syncope)	
Recherche les antécédents personnels	
Recherche les antécédents familiaux	
Recherche d'éventuelles allergies	
Demande les traitements en cours	
Recherche une consommation de toxiques (tabac, alcool…)	
Quantifie une consommation de toxiques (tabac, alcool…)	
Demande le mode de vie	
Stratégie diagnostique (examens complémentaires)	
Bilan sanguin : enzymes cardiaques (troponines, BNP)	
Radiographie du thorax de face	
Électrocardiogramme	
Échographie trans-thoracique	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à écouter le patient	1 à 5
Aptitude à questionner le patient	
Aptitude à structurer / mener l'entrevue	
Communication non-verbale	
Aptitude à proposer une prise en charge	

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

Ignore les réponses du patient/collègue			Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise de différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant le plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

4. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point

Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

5. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Interrogatoire	
Demande au patient le motif de sa venue	
Demande le moment d'apparition des symptômes	
Demande les éléments déclenchants des symptômes	
Évalue l'intensité de la dyspnée (demande dans quelles activités le patient s'est senti essoufflé / limité)	
Demande des précisions sur la gêne occasionnée en position allongée (nombre d'oreillers et/ou difficultés à s'endormir)	
Recherche la notion de palpitations	
Recherche la notion de sensation de malaise (lipothymie) / perte de connaissance (syncope)	
Recherche les antécédents personnels	
Recherche les antécédents familiaux	
Recherche d'éventuelles allergies	
Demande les traitements en cours	
Recherche une consommation de toxiques (tabac, alcool…)	
Quantifie une consommation de toxiques (tabac, alcool…)	
Demande le mode de vie	
Stratégie diagnostique (examens complémentaires)	
Bilan sanguin : enzymes cardiaques (troponines, BNP)	
Radiographie du thorax de face	
Électrocardiogramme	
Échographie trans-thoracique	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à écouter le patient	Échelle de 1 à 5
Aptitude à questionner le patient	
Aptitude à structurer / mener l'entrevue	
Communication non-verbale	
Aptitude à proposer une prise en charge	